

Sémiologie.
Méthodologie de l'étude de cas

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

La composition d'une étude de cas

1. Schéma général (niveau I)

Une étude de cas se structure et se présente en reprenant les éléments recueillis dans le travail clinique et puis évalués au cours de l'analyse, et en les composant d'une manière qui s'appuie sur un schéma "historique", de référence, établi par J. Bergeret, qui propose d'examiner les éléments suivants :

- l'*anamnèse* et l'*histoire du sujet*
- la *sémiologie* (signes et symptômes)
- le *type d'angoisse* et la nature des *conflits psychiques*
- les *mécanismes de défense* utilisés par le sujet, relativement à ces angoisses et conflits
- le type de *relation d'objet* prévalent (incluant les questions de la position narcissique et de la culpabilité)
- l'*organisation* ou *structure de personnalité*, qui comprend l'histoire infantile, la construction œdipienne, les particularités de l'adolescence et les événements psychiquement significatifs de la vie adulte.

1.1. Présentation du patient

On trouve là les données qui correspondent à l'état civil, et quelques éléments d'intérêt pour la personne ou la situation, typiquement et notamment :

- l'âge, la situation personnelle, et professionnelle ;
- les antécédents personnels et familiaux.
- également les éléments médicaux, si nécessaire
- on indique également les conditions et motifs de consultation, ainsi que les éléments relatifs à la demande du patient

1.2. Sémiologie

Quand cela est possible, on commence par présenter la chronologie des troubles, avec des indications concernant :

- les modes d'entrée et de sortie de la pathologie (pour les symptômes *perceptibles*),
 - son caractère aigu ou chronique
 - et son évolution
- > il s'agit bien sûr de la *manifestation* des troubles et non des causes des troubles (qui peuvent parfois s'originer avant la naissance)

Apparaissent ensuite dans cette même rubrique les données essentielles de la sémiologie, et c'est généralement la partie la plus longue. Il s'agit là de présenter les signes cliniques, *ordonnés par catégories*.

Il est important de mettre de l'ordre, parce que cette catégorisation porte un principe d'intelligibilité. C'est là où la connaissance en psychopathologie vient relayer la démarche clinique.

1.3. Diagnostic psychiatrique

Un premier moment de synthèse est possible ici en livrant un diagnostic psychiatrique, au vu de la sémiologie, et en procédant si nécessaire à un diagnostic différentiel. Cela permet d'indiquer le type de maladie dont le sujet est atteint, et de sa forme clinique.

L'établissement du diagnostic dépendant de la qualité du travail d'ordonnancement opéré dans la rubrique précédente.

1.4. Types d'angoisse

La question du *type d'angoisse*, ensuite, constitue la rubrique charnière entre les deux volets psychiatrie et psychopathologie : il s'agit là de décrire :

- d'une part, les manifestations symptomatiques de l'angoisse (symptômes simples)
- d'autre part, les conflits fondamentaux qui correspondent à ces angoisses

1.5. Mécanismes de défense

Il s'agit ensuite d'indiquer les mécanismes de défense repérables dans l'observation, qui apparaissent le plus souvent en lien avec la symptomatologie

1.6. Relations d'objet

On décrit dans la rubrique suivante les types de relations que le sujet entretient avec son monde et ceux qui vivent dans ce monde, selon les trois axes suivants :

Les relations à autrui

Cela commence par les relations avec les autres, qui sont évidemment le point sensible et significatif des problématiques en psychopathologie. On entend donc tout d'abord la notion de relation d'objet au sens strict, puisque l'objet en question est un autre sujet

La culpabilité

Ensuite, il s'agit d'indiquer les manifestations de culpabilité (névrotique ou psychotique), qui relève aussi du rapport au monde et aux autres

Le narcissisme

On procède également à la description des positions et problématiques narcissiques, qui constituent un autre axe de la construction de la personne, en lien bien sûr avec le monde extérieur

Relation avec le psychologue

C'est aussi dans ce cadre de la relation avec les autres que peuvent être mentionnées les particularités de la *relation* entretenue entre le patient et le psychologue/thérapeute.

1.7. Organisation/structure de la personnalité

Il s'agit alors, dans la dernière partie, de mettre tous les éléments en lien pour obtenir une vue d'ensemble sur la personne.

Histoire

Cela commence par les éléments significatifs de l'histoire personnelle et psychique (au-delà de l'anamnèse, qui se limite au médical), en particulier les situations et événements de vie majeurs :

- auxquels la personne a dû se confronter
- et qui ont donc été déterminants dans sa construction, comme des séparations, des deuils, des rencontres, etc.

Construction œdipienne

Du côté de l'histoire résolument psychique, il s'agit également de procéder à la description de la position du sujet par rapport à l'Œdipe : dépassement ou fonctionnement pré-œdipien.

Cela inclut par exemple et notamment la description des imagos parentales.

Synthèse (évaluation psychopathologique)

On arrive ainsi à cette dernière rubrique qui rassemble tout ceci dans l'organisation d'une personnalité :

- avec ses traits normaux et pathologiques
- souvent rendus compréhensibles lorsque l'on connaît les aspects problématiques de l'histoire de la personne.

2. Présentation détaillée (niveau II)

Chaque situation crée ses outils et sa position ; la pratique de psychologue n'est pas la pratique psychiatrique ni psychanalytique. Pour fixer les idées sur les différents niveaux de l'analyse d'un cas - ou de la manière idéale dont peut être présenté un dossier après l'enquête - on peut reprendre le modèle suivant :

2.1. Analyse sémiologique

Elle consiste en une reprise de tous les signes et suppose donc la connaissance de l'ensemble de ces signes. Dans le cas des psychoses, il appartient au clinicien de rechercher les signes évocateurs d'idées délirantes, d'hallucinations, de discordance, de troubles du cours de la pensée, de troubles majeurs du comportement, signes qui se repèrent autant dans ce que dit le malade, que dans la relation qu'il établit avec le psychologue. Il ne saurait toutefois être question de se limiter à ces seuls signes ; il convient de relever aussi les signes généraux. Cette analyse doit nécessairement (sauf si l'on manque de certains éléments) reprendre :

- le motif de consultation
- les antécédents personnels et familiaux
- l'histoire des troubles (ou histoire de la maladie),
- l'anamnèse
- les événements récents
- la nature de l'épisode actuel (analyse sémiologique complète de l'épisode actuel), qui vise à mettre en évidence la présence de certains syndromes (au sens de regroupement de signes) et l'absence de certains signes qui pourraient être essentiels. Cette description de l'épisode actuel est un point important. La lecture sémiologique de ce qui est présenté par le patient se double donc d'une enquête sur ce qui n'est pas présent (et donc pourrait être présent) :
 - la sémiologie de la personnalité
 - la sémiologie des mécanismes de défense
 - les éléments médicaux
 - l'évolution

Cette lecture aboutit à un regroupement syndromique qui va permettre la discussion du diagnostic (en termes de maladie). Elle suit les lois habituelles du diagnostic médical et/ou psychiatrique et procède à une production des signes et à une transformation des symptômes en signes, qu'il s'agisse des signes de maladie ou des traits de personnalité. A ce niveau peuvent intervenir des échelles d'évaluation, voire des questionnaires de personnalité.

Cette analyse sémiologique est naturellement un inventaire qui doit être ordonné. Mais il serait faux de penser que la sémiologie se passe de toute interprétation. Reconnaître une hallucination et la définir comme psychique, par exemple, est un acte et suppose une interprétation conditionnée par la connaissance, l'expérience, et pouvant faire l'objet d'une discussion ; il faut cependant des arguments et non pas seulement des "impressions".

2.2. Analyse diagnostique

Ce deuxième niveau suit nécessairement le premier qui lui sert de préalable. Le regroupement des signes en tableaux ordonnés permet la reconnaissance de la maladie, la discussion de sa forme clinique, et l'exclusion des autres possibilités. La démarche est déductrice et correspond à une certaine logique qui peut être figurée sous la forme d'arbres décisionnels. Certains seront fournis ultérieurement.

2.3 Analyse psychopathologique

Étude du « mode de fonctionnement mental du sujet »

En s'appuyant sur le schéma de Bergeret, on peut développer la démarche suivante :

- étude des mécanismes de défense, dont il convient de connaître la liste, les formes et l'importance
- étude du symptôme et de la demande
- étude des modes d'investissements libidinaux (relation d'objet)
- étude de la nature du conflit psychique
- analyse de la relation avec l'interlocuteur (qui ne se confond pas avec l'analyse de la demande).

Analyse de l'histoire du sujet

Le principe de ce mode d'analyse, qui est complémentaire du précédent, est de s'appuyer sur le récit de la vie du sujet telle qu'il la raconte. Il va alors être possible de relever des "faits saillants" (événements externes) mais ce qui importe, ce sont :

- les liens temporels qui sont établis par le psychologue dans la linéarité de l'histoire : cette analyse diachronique permet de faire des hypothèses sur les réactions possibles du sujet.
- les faits saillants de l'histoire tels que le sujet les rapporte et la manière dont il les interprète. Il s'agit en fait d'une analyse synchronique puisque ce qui importe c'est ce que dit le sujet au moment où il parle (hic et nunc : ici et maintenant).
- les répétitions de son histoire.
- les zones inabordables.

Cette approche doit être considérée comme clinique puisqu'elle prend en compte différents aspects du sujet.

Étude de la structure

Selon les paradigmes auxquels on se réfère, ce point peut se confondre avec l'analyse du fonctionnement d'un sujet ou bien être totalement différent. Définir la structure n'est toutefois pas suffisant, la question est celle de la singularité, c'est-à-dire des modalités de cette structure chez le sujet : définir une structure hystérique est une chose, mais la question est de savoir comment elle est manifestée par ce sujet.

On peut par ailleurs considérer que l'analyse de la structure peut aussi s'appuyer sur le repérage des répétitions (dans le discours du sujet) et de ce qui pourrait être appelé "signifiants électifs". Certains propos du sujet sont ainsi particulièrement déterminants dans son histoire dans la mesure où ils

condensent et rendent manifestes des éléments de la structure.

Interprétation clinique

L'ensemble des éléments précédents doit aboutir à une analyse clinique des différentes positions du sujet. Cette analyse clinique représente la formulation d'une série d'hypothèses tenant directement compte de la singularité de ce sujet et non un placage de théories ou de modèles tout faits.

Parler d'analyse psychopathologique, c'est donc se référer à des paradigmes permettant de faire des hypothèses soit sur la pathologie considérée, soit sur la manière dont se constitue le sujet. On voit aussi apparaître la question de la nécessité d'une forme de diagnostic, d'évaluation diagnostique, ou de représentation des problèmes. Ce diagnostic opère à plusieurs niveaux, mais il ne constitue pas forcément une réponse. Il faut en effet distinguer le diagnostic qui permet de nommer les symptômes et la maladie, et le diagnostic qui permet, en définissant une structure ou un mode de fonctionnement, de poser certaines questions au matériel clinique, de faire certaines hypothèses (représentation des "possibles") à partir de la théorie de la structure concernée.

Exemple (sémiologie simple) : Monsieur T., 48 ans

Lôo Henri, Olié Jean-Pierre, Cas cliniques en psychiatrie, Paris, Flammarion, 2009

Ce premier cas propose une analyse rapide des éléments sémiologiques élémentaires d'un cas de jalousie délirante.

Monsieur T., âgé de 48 ans, cadre dans une petite agence bancaire, est amené aux urgences par la police après avoir agressé un commerçant. À l'entretien, Monsieur T. se révèle agressif verbalement et physiquement. Il explique avec véhémence qu'il entend bien « laver son honneur, dans le sang si besoin ». Il précise que sa femme a quitté leur appartement pour aller chez sa sœur : « Sa sœur est dans le coup, j'en ai la preuve, les indices concordent : elle me trompe. Je l'ai découvert il y a 4 mois déjà. » Il a ainsi repéré que sa femme a changé de parfum, et que les commerçants lui font des clins d'œil. « Hier encore, elle est arrivée en retard, c'est le 5-à-7, c'est évident. »

L'entourage de Monsieur T. indique que ce dernier a toujours été très possessif, particulièrement suspicieux et peu ouvert aux discussions. C'est lui qui organise la vie de son agence bancaire, cette discipline ayant été à l'origine d'un conflit avec le siège de la banque depuis que deux employées au guichet ont souhaité leur mutation. Depuis le décès de son père il y a 2 ans, Monsieur T. s'est mis à boire, se montrant parfois violent lorsqu'il est ivre. Néanmoins Monsieur T. poursuit son activité professionnelle, semble-t-il avec efficacité, ces débordements ne se produisant qu'en soirée.

Quel est le diagnostic pour l'épisode actuel ?

- | | |
|--|---|
| <p>Délire paranoïaque passionnel de jalousie, devant :</p> <ul style="list-style-type: none">- syndrome délirant ;- aigu (moins de 6 mois) ;- à thème de jalousie ;- mécanismes interprétatif (retard de l'épouse, clins d'œil des commerçants) et intuitif ;- systématisé ;- organisation en secteur : vie professionnelle non | <p>envahie par ce délire ;</p> <ul style="list-style-type: none">- adhésion totale ;- participation émotionnelle forte sans organisation sur un pôle exclusivement dépressif ou maniaque ;- pas de syndrome dissociatif ;- terrain : homme, alcoolisme, facteur déclenchant (décès du père). |
|--|---|

Que dire de la personnalité ?

- | | |
|---|--|
| <p>Personnalité paranoïaque :</p> <ul style="list-style-type: none">- psychorigidité (peu ouvert aux discussions) ;- méfiance (possessif et suspicieux) ;- hypertrophie du Moi ;- méfiance, susceptibilité ; | <ul style="list-style-type: none">- fausseté du jugement, absence d'autocritique. <p>NB : un délire paranoïaque peut survenir en l'absence de trouble de la personnalité, ou en lien avec un autre trouble de la personnalité.</p> |
|---|--|

Exemple : Monsieur J. 21 ans, schizophrénie

Cette étude re-précise tout d'abord les éléments méthodologiques présentés schématiquement plus haut, en les appliquant au cas de Monsieur J.

1. Observation

1.1. Présentation du cas

Les mots soulignés désignent un signe qu'il faut reconnaître et nommer ; la lettre entre parenthèses renvoie à cette nomination

Monsieur J., 21 ans est amené par sa mère à la consultation de psychiatrie. Elle nous dit que c'est à la suite d'une rupture sentimentale (A) que son fils aurait "craqué" nerveusement. Elle précise qu'il s'est renfermé sur lui-même (B), a perdu l'appétit (C) et a beaucoup maigri (D) ; il se réveillait tôt le matin (E), ruminant la perte de son amie (F), ne trouvant plus d'issue pour lui (G) car certain de ne plus pouvoir aimer. C'est 15 jours après l'apparition de ces troubles que M. J. aurait commencé à présenter des troubles du comportement. D'après la mère, il serait devenu bizarre (H), parlant seul (I) dans sa chambre, éclatant de rire sans savoir pourquoi (J) lorsque sa mère lui demandait de venir dîner.

A l'entretien, le discours de M. J. est lent (K) et incohérent (L), mais on peut y saisir des fragments de pensée délirante : "mon sexe a été mutilé (M), des micros enregistrent mes pensées (N), je suis surveillé (O) par mon ancienne amie et toutes les femmes du monde sont ligüées contre moi pour me punir d'une faute que je n'ai pas commise (P)". La plupart du temps M.J. est apragmatique, paraît triste (Q)".

L'entretien avec la mère nous apprend qu'en réalité son fils "ne va pas bien depuis 3 ans (R)". Elle en a brutalement pris conscience, il y a un an, le jour où il a tenté de forcer la porte de sa chambre à coucher car il fallait, disait-il, "coucher avec sa mère pour réaliser son oedipe et être bien (S)" Mais elle avait déjà constaté des attitudes bizarres chez lui : "Il se regardait sans arrêt dans la glace (T), ne sortait presque exclusivement que (U) pour consulter des médecins, prétextant une transformation anormale de son sexe (V) et le caractère inesthétique de son nez qui lui valait les regards hostiles et méprisants des gens dans la rue (W)".

Depuis 3 ans son isolement social (X) ne faisait que croître ; à 20 ans, il avait abandonné une licence de psychologie dès la première année et cherchait depuis "un petit boulot" (Y).

1.2. Recueil sémiologique élémentaire

Avant d'entreprendre cette analyse, il faut préciser que les informations contenues dans cette observation sont étroitement dépendantes du discours de la mère. Bien que ce type de situation soit assez fréquent, bien que les données de l'entretien avec le patient confirment les informations données par la mère, une nécessaire prudence est de règle devant le discours des proches. Pour des raisons pédagogiques, nous traiterons cependant ce matériel

comme fournissant des informations valides et fiables. Dans la pratique clinique quotidienne, les proches peuvent être sujets à des erreurs d'interprétation, il peut leur arriver de minimiser ou de maximiser les informations, et, en quelques occasions d'être de mauvaise foi. Contrairement à ce qui se produit dans les situations cliniques, cette observation a déjà regroupé certains éléments, a nommé quelques signes et a conservé les informations essentielles.

(A) Facteur déclenchant (pour la mère qui, d'ailleurs, se contredira) de l'épisode : rupture sentimentale

(B) Repli sur soi (symptôme d'interprétation ambiguë car se retrouve dans plusieurs types de troubles)

(C) & (D) Anorexie et amaigrissement (symptôme d'interprétation ambiguë car se retrouve dans plusieurs types de troubles : épisode dépressif, anorexie mentale, sitiophobie... ; faire préciser les raisons pour lesquelles il ne mange pas)

(E) Insomnie de fin de nuit

(F) Ruminations mentales

(G) Pessimisme (peut-être perte d'espoir ; à vérifier)

(H) Bizarrerie du comportement

(I) Parle seul (soliloque ou dialogue hallucinatoire ; à préciser)

(J) Rires immotivés

(K) Lenteur du discours => Bradypsychie, troubles du cours de la pensée ?

(L) Incohérence verbale

(M) Idée délirante à thème hypocondriaque (ou "somatique")

(N) Vol de la pensée (signe d'automatisme mental)

(O) Idée délirante de persécution (ou de référence ?)

(P) Idée délirante de persécution (mais aussi de culpabilité non congruente à l'humeur)

(Q) Apragmatisme, tristesse (éléments dépressifs ?)

(R) Début des troubles il y a trois ans => le trouble est chronique

(S) Troubles du comportement à caractère bizarre, déréel. Le contenu archaïque de la pensée entraîne une conduite instinctuelle inadaptée pouvant évoquer la prééminence du monde intérieur sur la réalité (indice de la pensée autistique du schizophrène). Rationalisme morbide et hermétisme.

(T) Signe du miroir (souvent sous-tendu par un sentiment de transformation corporelle ou de perte de l'identité)

(U) Dégradation du mode de fonctionnement antérieur ; isolement social, repli sur soi

(V) Idée délirante hypocondriaque (transformation corporelle)

(W) Idées délirantes de persécution, de référence et de transformation corporelle (dysmorphophobie).

(X) Isolement social depuis trois ans

(Y) Détérioration du mode de fonctionnement. Fléchissement scolaire pouvant évoquer des troubles du cours de la pensée.

|

2. Etude de cas (niveau I - licence)

2.1. Présentation du patient

Monsieur J. est un jeune homme de 21 ans, amené en consultation de psychiatrie par sa mère. Il vit avec elle et ne dispose pas d'autonomie professionnelle stable : il a interrompu une licence de psychologie dès la première année et cherche depuis un « petit boulot », sans réel projet construit.

Aucun antécédent somatique ou psychiatrique personnel ou familial n'est clairement documenté dans l'observation disponible. L'essentiel des informations provient du discours de la mère, ce qui nécessite une certaine prudence dans l'interprétation, même si le discours du patient confirme plusieurs éléments.

Selon la mère, les difficultés de son fils dureraient depuis environ trois ans, avec un repli progressif, un isolement social marqué, des comportements jugés « bizarres », ainsi qu'une préoccupation intense pour son apparence corporelle. Elle décrit également un épisode plus aigu récent, survenu après une rupture sentimentale, qui a motivé la demande de consultation.

Le motif immédiat de consultation est donc la dégradation récente du fonctionnement de Monsieur J. (modification du comportement, propos délirants, retrait massif), sur fond de troubles anciens.

2.2. Sémiologie

Chronologie et mode d'évolution

Les troubles semblent s'inscrire dans une temporalité en deux temps :

1. Troubles anciens (depuis environ 3 ans, vers 18 ans)

Isolement social croissant, repli sur soi.

Abandon des études universitaires.

Préoccupations corporelles envahissantes : il se regarde longuement dans le miroir, se plaint d'une transformation anormale de son sexe et de l'aspect inesthétique de son nez, persuadé d'attirer les regards hostiles des passants.

Fréquentation répétée de médecins pour ces plaintes somatiques (dysmorphophobie, idées hypocondriaques).

On peut déjà repérer une dégradation du fonctionnement antérieur, une désinsertion progressive et un début de discordance (bizarreries comportementales, rapport altéré à son corps et au regard d'autrui).

2. Épisode récent (facteur déclenchant : rupture sentimentale)

Selon la mère, la rupture avec sa petite amie aurait entraîné un « craquage nerveux ». Dans les semaines qui suivent apparaissent :

- Un *syndrome dépressif* : perte de l'appétit et amaigrissement, réveils précoces, ruminations

autour de la perte de l'amie, pessimisme important, tristesse, apragmatisme et ralentissement du discours.

- Puis des *troubles du comportement* : Monsieur J. devient « bizarre », parle seul dans sa chambre, rit sans raison apparente.
- Enfin, des *idées délirantes* et un discours de plus en plus incohérent.

L'évolution globale est *chronique*, sur trois ans, avec un ajout récent d'une symptomatologie thymique et délirante, sans retour à un fonctionnement antérieur satisfaisant.

Signes cliniques principaux

Sphère thymique

On relève :

- Anorexie et amaigrissement.
- Réveil matinal précoce.
- Ruminations centrées sur la rupture sentimentale.
- Tristesse, apragmatisme, pessimisme.

Sphère de la pensée

- Lenteur du discours, pouvant évoquer une bradypsychie.
- Incohérence verbale par moments.

Le discours de Monsieur J. à l'entretien est lent et parfois incohérent, mais laisse apparaître plusieurs idées délirantes :

- Conviction que son sexe a été mutilé.
- Croyance que des micros enregistrent ses pensées.
- Sentiment d'être surveillé par son ancienne amie.
- Conviction que toutes les femmes du monde sont liguées contre lui pour le punir d'une faute qu'il affirme n'avoir pas commise.

Les thèmes sont donc :

- Hypocondriaque / somatique (mutilation du sexe, transformation corporelle).
- Persécution et référence (surveillance, complot des femmes).
- Culpabilité (idée de faute, même niée).

Le délire apparaît non systématisé, avec plusieurs thèmes juxtaposés, sans organisation paranoïde rigoureuse. Les idées délirantes sont non congruentes à l'humeur : les thèmes de persécution et de complot ne s'inscrivent pas simplement dans une logique dépressive.

Les mécanismes évoqués sont essentiellement intuitifs (les idées s'imposent au sujet). On note un phénomène d'automatisme mental (vol de la pensée), même si les hallucinations psychiques ne sont pas décrites de façon détaillée.

Sphère comportementale et relationnelle

On retrouve :

- Repli sur soi, isolement social marqué.
- Rires immotivés.
- Paroles proférées seul dans sa chambre.
- Tentative passée de forcer la porte de la chambre de sa mère pour avoir un rapport sexuel avec elle, justifié par la nécessité de « réaliser son Œdipe » pour aller mieux.
- Préoccupations narcissiques autour de l'image dans le miroir.

Ces manifestations évoquent :

- Des troubles du comportement à tonalité bizarre, parfois transgressive.
- Une discordance dans les attitudes et affects (détachement, comportements inadaptés, rire sans lien avec le contexte).
- Une difficulté à distinguer fantasme et réalité, notamment dans le rapport à la mère.

2.3. Diagnostic psychiatrique

Au vu de la sémiologie, plusieurs éléments s'imposent :

1. Un *syndrome dissociatif* (discordance) apparaît central : bizarrerie du comportement, rires immotivés, repli sur soi, isolement social, altération du cours de la pensée, détachement vis-à-vis de la réalité.
2. Un *syndrome délirant chronique*, non systématisé, à thèmes multiples (hypocondriaque, transformation corporelle, persécution, référence, culpabilité), avec mécanisme surtout intuitif et éléments d'automatisme mental.
3. Un *syndrome dépressif* récent, secondaire sur le plan chronologique, faisant suite à une rupture et s'ajoutant à une organisation déjà compromise.

L'évolution s'étale sur au moins trois ans, chez un sujet jeune, avec altération progressive du fonctionnement et absence de retour à la normale.

Dans ce cadre, l'hypothèse diagnostique principale est celle d'une schizophrénie, avec trouble thymique associé, plutôt qu'un trouble thymique primaire ou un délire chronique systématisé. Les diagnostics de bouffée délirante aiguë ou de mélancolie délirante ne sont pas retenus, notamment en raison de la chronicité et de la place centrale de la dissociation.

Ainsi, on peut proposer : *Schizophrénie avec troubles thymiques secondaires (hypothèse clinique)*.

2.4. Types d'angoisse

Le tableau clinique laisse supposer des angoisses psychotiques profondes, même si elles ne sont pas toujours directement verbalisées comme telles. On peut notamment évoquer :

- *Angoisse de morcellement* : l'idée de mutilation du sexe, la transformation du corps, le sentiment d'atteinte de l'intégrité corporelle renvoient à une peur de désintégration du corps et du moi.
- *Angoisse d'intrusion* : l'impression que ses pensées sont enregistrées par des micros, que des éléments externes pénètrent sa vie psychique, illustre une impossibilité de maintenir une frontière stable entre intérieur et extérieur.

- *Angoisse de persécution* : le complot supposé de « toutes les femmes du monde », la surveillance par l'ancienne amie, traduisent une expérience du monde comme persécuteur.

On peut donc distinguer, dans une perspective psychodynamique :

- D'un côté, des manifestations symptomatiques de l'angoisse : idées de mutilation, de surveillance, de complot, conduites bizarres.
- De l'autre, des conflits fondamentaux centrés sur l'intégrité du moi, la différence des sexes, la place dans le regard féminin et la capacité à se séparer.

2.5. Mécanismes de défense

Plusieurs mécanismes de défense, typiques des organisations psychotiques, peuvent être repérés :

- *Déni de la réalité* : la conviction inébranlable d'une mutilation du sexe ou d'une transformation corporelle, malgré l'absence de constat médical, illustre un refus de la réalité partagée.
- *Projection* : les affects internes (angoisse, hostilité, culpabilité) sont attribués à l'extérieur ; ce sont « les femmes » qui lui veulent du mal, qui sont liguées contre lui, qui le surveillent.
- *Identification projective* (au moins comme hypothèse) : le patient semble mettre dans l'autre (mère, amie, femmes en général) des contenus internes menaçants, tout en restant pris dans un lien envahissant avec ces objets.
- *Régression* : le fonctionnement mental revient à des positions très archaïques (confusion dedans/dehors, symbolique peu opérante, rapport direct et concret aux fantasmes sexuels et incestueux).

Dans l'ensemble, ces défenses sont peu contenantes et participent à la construction d'une néoréalité délirante destinée à rendre supportable une expérience interne très angoissante.

2.6. Relations d'objet

Relations à autrui

Les relations à autrui sont marquées par :

- Un isolement social important : retrait des relations, abandon des études, repli dans la chambre.
- Des difficultés majeures de distanciation : la frontière entre lui et l'autre apparaît peu stable (tentative de relation sexuelle avec la mère pour « réaliser son Œdipe », impossibilité de supporter la séparation avec l'amie).
- Une expérience de l'autre très ambivalente : l'amie est à la fois investie, puis vécue comme persécutrice ; les femmes sont perçues comme une entité menaçante et toute-puissante.

Plus que des objets totaux différenciés, les autres semblent souvent fonctionner comme des objets partiels ou des figures persécutrices globales (Toutes les femmes, La Mère).

Culpabilité

Monsieur J. évoque une « faute » pour laquelle il serait puni, tout en affirmant qu'il ne l'a

pas commise. Cette référence contradictoire à la faute peut être l'expression d'une culpabilité diffuse et mal élaborée, typique des organisations psychotiques : la faute n'est pas clairement symbolisée, mais projetée sur les autres (ce sont elles qui lui en veulent), et déniée dans le discours.

Narcissisme

On retrouve des éléments très marqués de fragilité narcissique :

- Préoccupations intenses pour l'apparence physique (nez, sexe), signe d'une image du corps instable.
- Observation fréquente dans le miroir, oscillant entre fascination narcissique et rejet de soi.
- Position mégalomaniacale paradoxale : il se vit comme la cible de « toutes les femmes du monde », ce qui le place à la fois en position de victime et de personnage central de leur complot.

Le narcissisme apparaît profondément atteint, avec une difficulté à stabiliser l'estime de soi et l'identité.

Relation avec le psychologue / thérapeute

Les données sur la relation au clinicien sont limitées dans le matériel fourni. On sait cependant que le contact n'est pas décrit comme syntone et que le patient semble peu engagé dans une demande personnelle : la consultation est surtout portée par la mère. On peut supposer que la relation thérapeutique sera d'emblée prise dans ces problématiques de projection, de persécution et de confusion des places.

2.7. Organisation / structure de la personnalité

Histoire subjective et événements significatifs

L'histoire de Monsieur J. est marquée par :

- Un début de désorganisation vers 18 ans, avec isolement, préoccupations corporelles et repli.
- Des difficultés à investir un projet d'études et une vie sociale structurée.
- Une relation très particulière à la mère, avec une tentative de transgression incestueuse vécue comme "nécessaire" à son équilibre.
- Une relation amoureuse dont la rupture semble agir comme point d'actualisation et de décompensation, faisant apparaître symptôme dépressif et un délire manifeste.

Ces événements peuvent être compris comme autant de moments de confrontation à la séparation, à l'altérité et à la différence des sexes, qui mettent en difficulté une structure déjà fragile.

Construction œdipienne

La manière dont Monsieur J. parle de « réaliser son Œdipe » en ayant un rapport sexuel réel avec sa mère témoigne d'une confusion majeure entre fantasme et réalité.

Ce qui, dans les névroses, reste de l'ordre du fantasme inconscient, est ici agi ou envisagé dans la réalité. Cela suggère une structuration œdipienne défaillante : la Loi de l'interdit de l'inceste n'est pas intégrée symboliquement, et la place du père est très peu présente, voire absente, dans le récit.

On est donc moins face à un conflit œdipien névrotique que face à une organisation psychotique où le matériel à contenu œdipien n'est pas symbolisé mais se manifeste directement dans les conduites et le délire.

2.8. Synthèse psychopathologique

En rassemblant les éléments précédents, on peut proposer, au niveau I, le portrait suivant :

- Sujet jeune présentant une organisation psychotique, avec fragilité narcissique profonde, angoisses archaïques (morcellement, intrusion), et défenses psychotiques (déli, projection, néoréalité délirante).
- Structure schizophrénique vraisemblable, au vu de la dissociation, de la désorganisation du cours de la pensée, de la bizarrerie comportementale, de la chronicité et du délire non systématisé.
- L'histoire relationnelle (lien fusionnel et ambigu à la mère, impossibilité de symboliser la perte de l'amie, défaillance de la loi œdipienne) et les événements de vie (puberté, séparation, échec des études) contribuent à éclairer la forme singulière que prend cette structure chez Monsieur J.

3. Etude de cas (niveau II - master)

3.1. Réorganisation de la sémiologie

Motif de la consultation

Consultation demandée par la mère. (NB : il serait intéressant, d'un point de vue psychopathologique, de savoir pourquoi la mère a attendu aussi longtemps et ce qui a motivé cette consultation).

Antécédents (personnels et familiaux)

Aucune information => à faire préciser (dans ce cas) par la mère.

Histoire des troubles

- Age de début probable : 18 ans
- Les épisodes antérieurs (ou plus exactement les comportements et manifestations antérieurs puisque les troubles paraissent constants) révèlent :
 - * des troubles du comportement évoquant la bizarrerie (S) (T), l'hermétisme (S) (T) et le repli sur soi (X)(Y)(U), voire la pensée autistique (T). Ces éléments suggèrent l'existence d'une discordance.
 - * des idées délirantes à thèmes hypocondriaque (V), de persécution, de référence (W) et une dysmorphophobie (W)
- La personnalité prémorbide est impossible à définir du fait de l'absence d'informations.

Épisode actuel

- Le mode de début est présenté comme aigu. Cependant, les troubles évoluent depuis trois ans et les thèmes semblent identiques. On ne peut donc considérer que le trouble est aigu. Il faut toutefois constater qu'une symptomatologie récente est venue s'ajouter à l'ancienne
- Il existe un facteur déclenchant (d'après la mère)
- L'accès actuel est caractérisé par trois types de manifestations :
 - . des signes évoquant un syndrome dépressif : troubles du sommeil avec réveil précoce, anorexie, rumination de la perte de son amie, pessimisme (ou perte d'espoir), tristesse et ralentissement. Certains de ces signes sont toutefois d'interprétation ambiguë et aucun n'est pathognomonique.
 - . des signes évoquant un syndrome délirant : (M), (N), (O), (P). Ce syndrome délirant présente les caractéristiques suivantes :
 - + Thèmes : hypocondriaque, transformation corporelle, persécution, référence
 - + Mécanismes : intuitif (les éléments s'imposent au sujet) ; la question de l'automatisme mental reste posée (à cause du vol de la pensée) mais on ne note pas d'hallucinations (pour l'instant car il est possible que les idées délirantes somatiques soient

sous-tendues par des hallucinations).

+ Systématisation : l'existence de thèmes différents qui ne sont pas rattachées entre eux amènent à le définir comme non systématisé.

+ Extension : impossible de répondre à cette question (d'ailleurs sans intérêt ici).

+ Participation émotionnelle : les idées ne sont pas congruentes à l'humeur

+ Chronicité ou acuité : d'après la mère les idées délirantes sont apparues depuis trois ans. Le délire peut être considéré comme chronique.

. des signes atypiques : bizarrerie (H), rires immotivés (J), incohérence verbale (L), hermétisme (S).

Ces différents éléments évoquent des signes de discordance dans la sphère du comportement (repli sur soi, signe du miroir, comportement avec sa mère...), de la pensée (idées délirantes) et de l'affectivité. On retrouve en effet : des bizarreries, un détachement de la réalité, un repli sur soi, des signes de pensée autistique. L'ambivalence n'est pas très présente encore que le fait de forcer la porte de sa mère et les idées de culpabilité puissent l'évoquer.

Éléments médicaux

Absence d'information

Évolution

Aucune information

Conclusion

- 1 - Apparition récente de signes dépressifs chez un sujet jeune
- 2 - présentant depuis trois ans un syndrome dissociatif
- 3 - avec des idées délirantes non systématisées, non congruentes à l'humeur, à mécanisme intuitif, des signes d'automatisme mental
- 4 - et des troubles du comportement (détachement de la réalité et conduites bizarres).

3.2. Discussion du diagnostic

La présentation de cette discussion peut se faire de plusieurs manières. Nous retiendrons ici la technique consistant à faire une hypothèse, à la justifier, à préciser la forme clinique, puis à exclure les autres possibilités.

Hypothèse

Cette hypothèse a été suggérée par le regroupement sémiologique - dont il convient de noter qu'il n'est pas neutre mais qu'il tient déjà compte de l'organisation des tableaux - qui nous laissait devant trois syndromes principaux (délirant, dépressif et des éléments atypiques) et nous avons souligné l'existence d'une discordance. Dans ce cas, la discordance est l'élément principal. Celle-ci est pathognomonique de la schizophrénie.

Nous faisons donc l'hypothèse de l'existence d'une schizophrénie

Toutefois, comme certains troubles d'étiologie organique peuvent fournir des tableaux qui ressemblent fort à la schizophrénie, il convient d'exclure cette possibilité. Ici, aucun signe ne va dans ce sens. Donc l'hypothèse est maintenue.

Justification de l'hypothèse

- 1- Il existe des idées délirantes non systématisées
- 2- Il existe des signes de dissociation d'évolution chronique
- 3- Les signes atypiques sont au premier plan du tableau actuel
- 4- Les thèmes délirants ne sont pas congruents à l'humeur dépressive
- 5- Les signes dépressifs sont d'apparition secondaire.

Définition de la forme clinique

Il existe plusieurs formes de schizophrénie (catatonique, hébéphrénique, paranoïde, pseudo-névrotique, héboïdophrénie, dysthymique, hébéphréno-catatonique, simple...). Il faut donc préciser la forme clinique. L'existence d'un syndrome dépressif oriente la recherche vers les formes thymiques.

1 - Il ne peut s'agir d'une schizophrénie dysthymique car les signes thymiques sont secondaires, il n'y a pas de périodicité et pas de restitution *ad integrum* entre les accès

2 - Nous sommes en présence d'une schizophrénie avec trouble thymique. L'absence d'informations concernant le délire invite à différer l'hypothèse d'une schizophrénie paranoïde avec trouble thymique. D'autre part les signes de discordance sont au premier plan par rapport au délire. Dans le cas du délire paranoïde, l'explosion délirante est généralement plus riche.

Exclusion des autres troubles

L'existence de troubles thymiques avec culpabilité, apragmatisme, transformation corporelle... aurait pu orienter le diagnostic vers une mélancolie délirante mais les signes dépressifs auraient dû apparaître avant les signes dissociatifs

La même démarche pourrait être répétée avec d'autres entités, encore qu'il s'agisse là d'une pure démarche scolaire. Exemples :

- Bouffée délirante : impossible car le trouble est chronique
- Délire chronique : impossible car non systématisé
- PHC (psychose hallucinatoire chronique) : impossible car les hallucinations sont secondaires au délire, les éléments hallucinatoires ne sont pas déterminants
- etc...

3.3. Lecture psychopathologique - repérage d'éléments

Cette lecture ne vise pas à reconnaître des signes mais à relever des éléments cliniquement

pertinents à cause de ce qu'ils impliquent soit quant à l'organisation de ce sujet (ce qui lui est propre) soit quant à la nature des processus en cause. Le repérage de ces éléments correspond en fait à un ensemble de questions que l'on peut se poser. Il va sans dire que différentes lectures psychopathologiques sont possibles et n'est présentée ici que l'une des facettes (se référant à la psychanalyse). La phénoménologie, la psychologie existentielle, ont chacune leurs techniques d'analyse qui mettent en évidence d'autres liens et d'autres hypothèses. De même, la lecture ici proposée ne saurait prétendre à l'exclusivité : la clinique est un domaine "ouvert" dans lequel il s'agit de se poser des questions pour aider le patient à modifier ses positions subjectives. Dans la pratique clinique, un psychopathologue ne perdra pas son temps à analyser les choses de cette manière et ira droit à l'essentiel en fonction, le plus souvent, de son expérience (analogie avec d'autres cas) et de son adhésion à certains paradigmes. Mais comme il s'agit ici d'illustrer les différents aspects d'une analyse psychopathologique, ils seront présentés avec leurs lacunes, leurs défauts et leurs excès. Pour éviter d'alourdir l'analyse, ne sont retenus dans un premier temps que quelques éléments qui ont été effectivement fournis par le patient ; seront donc laissés de côté les informations données par la mère, informations qui devraient être utilisées dans une analyse psychopathologique, à condition toutefois de bien considérer que ce qui provient du discours de la mère n'est pas à traiter de la même façon que ce que le sujet dit.

(M) "*Mon sexe a été mutilé*" : Il s'agit d'une plainte formulée comme une certitude et considérée comme une réalité. Noter l'utilisation du passé, la référence à l'anatomie, à la différence des sexes et à la castration, la notion de mutilation et l'utilisation de la voie passive. Quelle signification peut posséder une mutilation sexuelle pour le sujet ? (Questions que ne peut manquer de se poser le clinicien : évocation de la "castration", du "morcellement", modification de l'image du corps ?)

(N) "*des micros enregistrent mes pensées*" : Même remarque concernant la plainte formulée comme une certitude et considérée comme une réalité. A noter l'utilisation du présent, l'aspect indéfini ("des micros"), l'absence de désignation d'un persécuteur, et que c'est la pensée qui est en cause. Cette dernière est contrôlée (par qui ?) passivement. Noter aussi que l'expérience affecte uniquement le sujet et qu'il est au centre de l'expérience (il serait utile de lui demander si les micros n'enregistrent que ses pensées ou s'ils enregistrent aussi celles du thérapeute). La pensée qui est autonome est donc atteinte par quelqu'un, ou par quelque chose. Mais cette pensée est présentée implicitement comme une parole qui peut être enregistrée. (Questions que ne peut manquer de se poser le clinicien : quelle est cette machine qui enregistre, pourquoi enregistre-t-elle, s'agit-il d'un phénomène identique à celui de la "machine à influencer" de V. Tausk, peut-on considérer qu'il s'agit d'une identification projective, doit-on renverser la formule et situer le sujet comme enregistrant la pensée de quelqu'un d'autre, quels rapports le sujet établit-il entre pensée et parole.... ?)

(O) "*je suis surveillé par mon ancienne amie*" Noter la présence du "je" et de la voie

"passive" ; le patient est l'objet passif d'une expérience, l'accent est mis sur lui et non sur l'amie. La séparation est apparemment reconnue ("ancienne") mais il persiste un lien avec cette amie puisqu'elle le surveille. La surveillance est celle d'une femme avec laquelle une relation avait été nouée. (Questions que se posera sans doute un clinicien : le délire ne restitue-t-il pas une relation inversée (la relation existe toujours mais la surveillance a remplacé l'amour), s'agit-il d'une projection sur le modèle de celle définie par Freud dans Schreber (elle me surveille parce qu'elle me hait < je la surveille parce que je la hais < je la hais parce qu'elle ne m'aime plus), le délire est-il l'édification d'une néo-réalité, quels rapports y a-t-il entre cette surveillance et la mutilation de son sexe et les micros, peut-on considérer qu'il n'y a pas eu travail de deuil après la séparation, quel statut a cette amie (objet total ou objet partiel ou double narcissique)... ?

(P1) *"et toutes les femmes du monde sont liguées contre moi"* Noter ici la différence : les "femmes" deviennent l'élément central (elles sont le sujet de la phrase). Il existe donc un complot contre le sujet, complot uniquement féminin - les hommes n'en font pas partie. L'amie est à la fois distinguée des autres femmes et intégrée à elles. L'essentiel est ici le "toutes les femmes" (aucune n'y échappe, y compris sa mère !) ; il existe une entité globale féminine qui lui en veut. Cette conception appelle les mêmes questions que celles précédemment posées à propos de son amie : de quelle haine le sujet est-il porteur contre les femmes, femmes qui sont représentées auprès de lui par son ancienne amie et par sa mère ? L'expérience de ce patient apparaît-elle comme celle d'un homme sexuellement mutilé victime de toutes les femmes, c'est-à-dire peut-être de La Femme (représentée par l'amie et la mère) ? De quelle toute-puissance sont investies les femmes ? Que représentent sa mère et son amie ? Où est le père dans cette histoire ? Quels sont les bénéfices narcissiques d'être le seul homme face à toutes les femmes ?

(P2) *"pour me punir d'une faute que je n'ai pas commise"* Apparition d'une justification de l'attitude des femmes, de la notion de faute et d'une défense du sujet. L'expérience du sujet est celle de l'injustice, mais s'il l'on reconstruit la logique du délire on a les éléments suivants :

- mon amie me surveille
- généralisation derrière "toutes les femmes"
- camouflage du motif ("faute")
- défense contre ce camouflage avec utilisation de la négation ("que je n'ai pas commise")

Questions : de quelle faute s'agit-il ; doit-on retourner la formule et considérer que le sujet parle d'une faute commise par les femmes (amie et/ou mère) ? De quelle culpabilité s'agit-il ?

Le repérage des éléments essentiels donne donc les points suivants :

- mutilation sexuelle

- pensées enregistrées
- surveillance
- femmes
- faute non commise

Le délire place donc le sujet comme mutilé, victime de toutes les femmes - à cause d'une erreur - mais paradoxalement le fait d'être le seul homme face à ces femmes traduit l'existence d'une position pour le moins mégalomane : il est injustement victime, mais il n'est pas n'importe quelle victime.

3.4. Analyses psychopathologiques

La présentation qui suit est « scolaire » et n'a donc pas d'autre but que d'illustrer ce qui a été dit précédemment. Il va sans dire que le travail d'un clinicien se doit d'être un peu moins obsessionnel et un peu plus fin. D'autre part, l'aspect limité du matériel ne permet aucunement de conclure.

Étude du "mode de fonctionnement mental du sujet"

Etude des mécanismes de défense

- déni de la réalité : attesté au moins par la notion de "sexe mutilé"
- projection : attestée par son rapport aux femmes et à la faute (Pour Freud il existe dans ce mécanisme trois temps consécutifs : tout d'abord la représentation gênante d'une pulsion interne est supprimée, puis ce contenu est déformé, enfin il fait retour dans le conscient sous la forme d'une représentation liée à l'objet externe" (Bergeret J. Abrégé.. p. 98).
- identification projective : ici plus difficile à reconnaître mais peut être déduite du morcellement et de l'enregistrement de la pensée. C'est un terme introduit par Mélanie Klein pour désigner un mécanisme qui se traduit par des fantasmes, où le sujet introduit sa propre personne en totalité ou en partie à l'intérieur de l'objet pour lui nuire, le posséder et le contrôler.
- dédoubllement du Moi : ici l'utilisation de ce concept est discutable dans la mesure où il semble bien être en échec (il s'agit d'un mécanisme de défense contre l'angoisse de morcellement : "une partie du Moi va demeurer en contact opératoire avec la réalité non gênante pendant qu'une autre partie de ce même Moi va perdre tout contact avec cette réalité dans ce qu'elle présente d'angoissant pour lui, cherche à dénier tous les aspects trop angoissants et, au besoin reconstitue (délire) en compensation une néoréalité plus rassurante et plus désirée à la fois" (Bergeret J. Abrégé.. p. 106). Il s'agit naturellement d'un mécanisme psychotique.)
- régression : plus facile à cerner dans le discours de la mère désignant le comportement du patient ; cette régression est ici triple formelle, temporelle, topique à cause des manifestations hallucinatoires, du comportement et du mode de pensée ("Dans un processus psychique comportant un sens de parcours ou de développement, on désigne par régression

un retour en sens inverse à partir d'un point déjà atteint jusqu'à un point situé avant lui. Prise au sens topique, la régression s'opère, selon Freud, le long d'une succession de systèmes psychiques que l'excitation parcourt normalement selon une direction donnée. Dans son sens temporel, la régression suppose une succession génétique et désigne le retour du sujet à des étapes dépassées de son développement (stades libidinaux, relations d'objet, identifications, etc.). Au sens formel, la régression désigne le passage à des modes d'expression et de comportement d'un niveau inférieur du point de vue de la complexité, de la structuration et de la différence". (Vocabulaire de la psychanalyse). Toute situation de maladie mentale implique pour Freud un conflit et une régression plus ou moins importante).

Etude du type de relation d'objet

Il est certes plus facile ici de se servir de ce que dit la mère que de ce que nous fournit le discours du sujet. On peut toutefois noter : l'absence de distanciation objectale stable (enregistrement de la pensée), les éléments d'ambivalence (avec la mère), des éléments mettant en cause la distinction entre dedans et dehors (micros et pensée), la difficulté à gérer les manifestations pulsionnelles (avec la mère), l'aspect persécuteur de l'objet, la nature probablement partielle de l'objet (encore que ce soit difficile à percevoir sauf peut-être dans ce qui est mentionné de son propre corps et dans la manière dont il reconstruit la relation avec son ancienne amie à laquelle il fait jouer ce rôle particulier), l'absence de référence au père, les risques d'empiétement par l'objet (les femmes, les gens dans la rue), le mode de fonctionnement sans tenir compte de l'autre (relation à la mère). La relation à la mère semble étonnante puisque ce sujet vit avec elle, qu'il pense que les femmes sont toutes liguées contre lui et qu'il tente d'avoir un rapport sexuel avec elle. La question de l'interdit de l'inceste semble jouer un rôle particulier puisque sa transgression permet d'atteindre la jouissance. De manière schématique (car il nous faudrait plus d'éléments) on pourrait avancer qu'il existe une menace de relation fusionnelle (dans laquelle le sujet ne sait pas démêler ce qui est lui et ce qui est l'autre).

Etude du type d'angoisse

On peut nommer les éléments suivants : angoisse d'intrusion (micros), angoisse de destruction d'une partie du corps, angoisse de destruction de l'identité. Étant donnés les autres éléments on aurait tendance à conclure à une angoisse de morcellement.

Etude du symptôme et de la demande

La demande est celle de la mère et, pour l'instant, le sujet semble ne rien demander. Il faut donc déduire sa demande des plaintes qu'il formule concernant la persécution, la faute, le morcellement, le vol de la pensée. Le symptôme est ici une plainte concernant ce dont il est victime de la part de persécuteurs ; ce que le sujet met en avant c'est son corps, sa pensée et les femmes. D'une certaine manière la question porte, dans son délire, sur les femmes.

Etude des modes d'investissements libidinaux

Pour ce qui concerne l'extérieur, on perçoit seulement la dimension féminine des objets (femmes), ou, si l'on reprend le discours de la mère, les "regards" et elle-même. On notera que, dans le peu d'éléments que nous avons, la question du désir et de l'autonomie de ces objets n'est pas directement posée. En ce qui concerne les éléments propres à lui-même, il s'agit d'organes isolés (nez, sexe, pensée), de son image dans le miroir, témoignant peut-être d'une activité auto-érotique portant sur des objets partiels, et spéculaires. On pourrait faire une hypothèse en termes de stase de la libido du moi (Cf. S. Freud (1914) « Pour introduire le narcissisme ». Dans *La vie sexuelle*, 1969, P.U.F, Paris). Il faut tout de même s'interroger sur l'apparition de manifestations dépressives dont le sens n'est pas clair : qu'est-ce que la perte d'objet chez le psychotique ? existe-t-il un travail de deuil chez le psychotique ? qu'est-ce que le sujet a perdu ? De même la question de la prédominance de certains placements libidinaux chez ce sujet reste obscure.

Analyse des relations avec l'interlocuteur

L'observation ne les mentionne pas mais il ne semble pas que le contact soit syntone et que l'interlocuteur ait une quelconque importance.

Analyse de l'histoire du sujet

Rappelons que cette analyse procède de plusieurs manières : liens que l'on peut établir de l'extérieur dans la linéarité de l'histoire, répétitions de l'histoire relevées par le psychologue, manière dont le sujet reconstruit son histoire. Ici encore nous devons utiliser, faute de mieux, le discours de la mère. Mais on devrait, en toute rigueur s'intéresser à l'histoire de la mère selon les trois mêmes axes et réfléchir à la manière dont la mère perçoit (consciemment et inconsciemment) son fils, et ce point ne concerne pas seulement la mère mais aussi le père.

Liens temporels

L'épisode actuel est survenu après une relation sentimentale dont l'échec reste à discuter : sommes nous devant une situation "classique" dans laquelle le sujet ne supporte pas la séparation ou bien devant une situation dans laquelle le sujet ne tolérerait pas la relation elle-même parce qu'elle devenait dangereuse pour une partie de lui. Notons qu'une tentative de séduction de la mère (avec une certaine violence) a précédé d'un an l'épisode actuel. On peut reconstituer la pathobiographie de la manière suivante :

- il y a 3 ans (à 18 ans) début du processus
- période de dysmorphophobie qui concerne le nez et le sexe, d'attitudes bizarres et de fascination narcissique pour son image, et de persécution par le regard des autres (projection). Perte du contact avec la réalité
- tentative agie de transgresser le tabou de l'inceste, transgression présentée comme possible, nécessaire, procurant un plaisir et peut-être comme une auto-guérison,

NB : si le matériel paraît oedipien, il ne s'agit en rien d'une position oedipienne. La structuration oedipienne concerne les fantasmes inconscients et non le passage à l'acte réel ; ce type de comportement accompagné de sa justification et de son contexte est pratiquement toujours le fait de psychotiques. Si l'inceste n'est pas forcément le cas de sujets psychotiques, la manière dont ce sujet l'évoque, le rapport qu'il entretient avec les femmes dans son délire est un phénomène psychotique. Le propre de certaines psychoses est précisément de formuler directement, voire de réaliser ce qui, chez les névrosés, reste parfaitement inconscient. Chez le schizophrène le symbolique est réel. Une des plus grandes erreurs avec les psychotiques consiste à les considérer comme des névrosés sous prétexte qu'il existe chez eux des thèmes manifestes qui rappellent les thèmes révélés par la psychanalyse à propos des névrosés. Chez les psychotiques il existe bien un matériel à contenu apparemment oedipien, mais il n'y a pas de structuration oedipienne :

- relation (de quelle nature ?) avec une amie
- rupture
- apparition de manifestations dépressives puis, 15 jours après
- apparition de bizarreries comportementales, puis
- éléments dépressifs et délirants à thèmes projectifs de surveillance et de mutilation.

On remarque donc que la perte de son amie a été suivie d'un phénomène d'allure dépressive, rapidement accompagné de bizarreries qui se superposent à la tristesse, puis d'un délire mettant en cause les femmes. Cette succession peut apparaître comme une série de tentatives de réaction à une perte (dont on ne connaît pas la nature exacte). En effet, il est hautement probable qu'il ne s'agissait pas d'un objet total, mais d'un objet partiel qui d'objet bon est devenu persécuteur.

Répétitions de l'histoire

Le manque d'information nous empêche d'y répondre, mais que répète la séparation avec l'amie, quand le sujet a-t-il été persécuté par une femme, quand son sexe (et son nez, pourquoi pas ?) se sont-ils transformés (La question des transformations de la puberté doit être ici posée).

Reconstruction de l'histoire par le sujet

Le sujet est apparemment incapable de construire son histoire, les choses sont présentées sur le même plan. Il faudrait lui demander comment il évalue la situation en particulier en l'invitant à établir des relations de causalité entre la perte de son amie et la persécution par les femmes. De même il faudrait savoir comment il situe sa mère là-dedans et comment il interprète la demande de consultation.

Étude de la structure

Avec aussi peu d'éléments, elle est impossible. Toutefois on peut remarquer : la référence aux femmes et l'absence d'hommes, la présentification de la castration, l'empiétement par

l'Autre (toutes les femmes) en position déterminante, la tentative de transgression de la Loi de prohibition de l'inceste, la constitution d'une néoréalité mettant en scène la féminité, l'ambivalence autour du même objet (amie), l'occultation de la place de la mère (qui est pourtant là), l'occultation de la place du père, la réapparition dans le réel délirant de certaines questions... Plusieurs possibilités apparaissent

1ère ligne d'interprétation : L'utilisation des équations théoriques tirées de l'analyse de Schreber (Voir Freud S. (1911) Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa. In Cinq psychanalyses. 1953. Paris, PUF ; Lacan J. (1958) D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. In Ecrits. 1966, Paris, Seuil) permettrait de poser des questions quant à la position du sujet comme objet essentiel à l'ensemble des femmes (liguées contre lui). Une rapide équivalence entre "femmes" et "mère" permettrait de faire quelques hypothèses structurales sur la place que ce sujet croit occuper dans le désir de sa mère et dans la relation de toute-puissance qui les lie.

2ème ligne d'interprétation : On emploiera une "équation théorique freudienne" (Voir S Freud (1924) « Névrose et psychose », dans *Névrose, psychose, perversion*, Paris, PUF, 1973) : le "délire est un processus restitutif de guérison", il y a dans le délire un fondement de vérité historique, le délire remplace quelque chose qui a été dénié dans le passé... On s'interrogera alors sur l'identité entre la situation délirante et une situation infantile et sur ce que le délire dit de "vrai" quant aux incertitudes du sujet concernant la sexualité, la femme, les autres.

Ces deux lignes sont purement hypothétiques et ne servent qu'à interpréter le matériel. Elles pourraient être complétées par d'autres lignes faisant référence aux travaux de Mélanie Klein (fixation, position paranoïde-schizoïde, identification projective), à ceux de G. Pankow (image du corps), de Racamier... Le problème n'est cependant pas uniquement de ramener cette histoire à une généralité, mais aussi de cerner ce qui se passe chez ce sujet précis. Sur ce plan, il faut faire quelques hypothèses cliniques.

Hypothèses cliniques

1 - Une des premières choses qui frappent est la dimension de l'expérience corporelle de ce patient. Il rapporte - à nous ou à sa mère - des transformations qui, dans un autre contexte, pourraient évoquer des idées hypocondriaques. Cette plainte à propos de son corps traduit une expérience corporelle qui évoque la souffrance, alors que l'observation devant le miroir pourrait constituer une autre expérience moins destructrice pour le sujet. Cette plainte, cette contemplation, traduisent l'existence d'une modification de l'image consciente du corps et sans doute de l'image inconsciente. La demande est sans doute à reconnaître dans ce qu'il en dit au médecin. Mais l'origine de la modification de l'expérience corporelle est à situer ailleurs que dans le corps ; de quelles pensées ces manifestations sont-elles le représentant ?

2 - Le second élément concerne le rapport aux femmes. Pour contradictoire que soit son

discours, il n'en ressort pas moins que les femmes sont perçues comme dangereuses. Il ne s'agit aucunement d'en déduire qu'il ne fait que retraduire là le comportement réel de sa mère. Mais il est sans doute vrai que son inquiétude et son interrogation portent sur la différence des sexes, sur le désir de sa mère et sur ce qu'il est pour elle. Le complot, l'enregistrement de la pensée constituent des tentatives de réponses à ces questions. C'est sans doute ce qu'il est allé demander, sans s'en rendre compte, aux psychiatres. Cependant il faut aussi comprendre toutes ces tentatives comme des essais pour se démarquer de la toute-puissance prêtée à la mère qui n'est évidemment pas la mère réelle, mais l'Objet primordial (présent dans l'imaginaire maternelle) représenté par la mère réelle.

3 - L'épisode d'apparente transgression du tabou de l'inceste est à considérer non pas comme une réelle transgression, mais comme une complète ignorance de cette Loi. Dans son univers, il est tout à fait possible de réaliser ce genre de désir. Ce mode de fonctionnement régressif suppose que le sujet soit hors organisation oedipienne. Il est possible que l'expérience délirante de mutilation sexuelle puisse être mise en relation avec ce désir. Tout se passe comme si le sujet était agi dans le réel par ces désirs.

4 - L'existence de l'amie et l'apparition de manifestations dépressives laissent penser que l'amie possédait un statut particulier pour lui, statut différent des autres objets partiels. Sa capacité à se déprimer pourrait témoigner d'une tentative structurante d'élaboration de l'objet. Toutefois cette tentative a échoué ; les mécanismes de défense mis en place contre le processus schizophrénique ont été sans effets. Il est possible que le même type de situation se reproduise avec un thérapeute.

4. Etude de cas (perspective phénoménologique)

4.1. Présentation du patient

Monsieur J. est un jeune homme de 21 ans, amené en consultation de psychiatrie par sa mère. Il vit avec elle, ne travaille pas, et a interrompu une licence de psychologie dès la première année. Depuis, il recherche « un petit boulot », sans projet clair ni trajectoire professionnelle stable.

Selon sa mère, il « ne va pas bien depuis trois ans ». Elle décrit une transformation progressive de son fils : il se replie sur lui-même, sort de moins en moins, passe beaucoup de temps dans sa chambre, semble préoccupé par son apparence et par son corps. Elle rapporte également, depuis quelques semaines, un changement plus brutal, survenu après une rupture sentimentale : tristesse marquée, amaigrissement, propos étranges, comportements bizarres.

Le motif de consultation immédiat est donc la dégradation récente du fonctionnement de Monsieur J. (retrait massif, bizarreries, discours incompréhensible), sur un fond de troubles plus anciens.

Dans une perspective phénoménologique, on peut dire que ce qui amène Monsieur J. à la

consultation, ce n'est pas seulement une « maladie », mais une modification profonde de sa manière d'être au monde, telle qu'elle devient problématique pour lui et pour son entourage.

4.2. Sémiologie dans une perspective phénoménologique

Plutôt que de se limiter à une liste de symptômes, la phénoménologie cherche à décrire comment le monde, le temps, le corps et les autres sont vécus par le sujet.

Temporalité et évolution

L'histoire se présente en deux grands temps :

Depuis environ trois ans (vers 18 ans)

- Retrait progressif de la vie sociale.
- Abandon des études.
- Isolement dans la chambre.
- Préoccupations centrées sur le corps (nez, sexe, image dans le miroir).

On peut déjà supposer une altération de la temporalité vécue : le mouvement vers l'avenir (projet d'études, insertion sociale) semble s'éteindre. Le temps ne se structure plus autour de projets, mais autour de préoccupations répétitives (corps, regard des autres).

Épisode récent (après la rupture sentimentale)

- Tristesse, perte d'appétit, réveils précoces, ruminations autour de la perte de l'amie.
- Sentiment d'impasse (« ne trouvant plus d'issue pour lui »).
- Survenue de conduites bizarres (parler seul, rires immotivés).
- Apparition d'un vécu persécutif et de convictions délirantes.

Ici, la rupture semble agir comme un événement qui révèle ou accélère une perturbation déjà là : le monde devient plus menaçant, moins fiable ; le rapport à soi et au corps se fragilise davantage.

Expérience du corps et de soi

Le corps occupe une place centrale dans l'expérience de Monsieur J. :

- Il se regarde souvent dans le miroir, comme s'il essayait de vérifier ou de contrôler son apparence.
- Il se plaint de la « transformation » de son sexe, de son nez, qu'il juge anormal et laid.
- Il a la conviction que son sexe a été « mutilé ».

Phénoménologiquement, on peut dire que le corps propre, qui normalement est un point d'appui discret pour l'action dans le monde, devient ici objet de préoccupation permanente. Le sujet ne « habite » plus son corps de manière évidente ; il le regarde et l'éprouve comme quelque chose d'étrange, parfois étranger, porteur de menace et de souffrance.

L'expérience du corps ne va plus de soi : elle se distord, se fissure. Le corps devient un lieu d'inquiétude, de doute, de danger. On peut parler d'atteinte de l'évidence corporelle.

Expérience de la pensée

Monsieur J. rapporte que « des micros enregistrent [ses] pensées ».

Ce n'est pas seulement une croyance abstraite ; c'est l'expression d'un vécu d'aliénation de la pensée :

- Ses pensées ne lui appartiennent plus complètement.
- Elles semblent exposées, accessibles à un Autre indéfini.
- L'intériorité n'est plus un espace intime protégé, mais un lieu potentiellement violé.

Dans une perspective phénoménologique, on peut dire que la frontière entre intérieur et extérieur est devenue incertaine : ce qu'il vit comme « intérieur » (ses pensées) est vécu en même temps comme extérieur, soumis à un dispositif anonyme (« des micros »).

L'acte de penser n'est plus une activité personnelle fluide : c'est une expérience troublée, où le sujet se découvre observé, contrôlé, surveillé au plus intime de lui-même.

Expérience du monde et des autres

Le rapport aux autres est profondément transformé :

- Il a le sentiment d'être surveillé par son ancienne amie.
- Il est convaincu que « toutes les femmes du monde sont ligüées contre [lui] ».
- Il se sent exposé aux regards hostiles et méprisants des passants dans la rue.
- Il se replie de plus en plus, limitant ses sorties essentiellement à des consultations médicales.

Le monde social ne se présente plus comme un espace ordinaire de relations, mais comme un champ de menaces. Les autres ne sont plus des partenaires possibles, mais des agents d'un complot, des juges, des observateurs hostiles.

On peut parler d'un vécu de persécution et de dépersonnalisation relationnelle : Monsieur J. ne se sent plus sujet parmi d'autres sujets, mais centre passif d'un dispositif dont il est l'objet (surveillé, jugé, enregistré).

La relation à la mère est également très particulière : il a tenté de forcer la porte de sa chambre pour « coucher avec sa mère pour réaliser son Œdipe et être bien ».

Ici, l'agir semble traduire une confusion des rôles et des frontières : la mère n'est plus seulement un parent, mais l'objet d'une tentative de réparation ou de solution (« être bien ») dans un monde devenu insoutenable. La Loi symbolique (l'interdit de l'inceste) semble ne plus fonctionner comme repère intérieur.

Tonalité affective globale

Si l'on regarde au-delà des signes isolés, on perçoit une tonalité affective fondamentale :

- sentiment de menace diffuse,
- expérience d'injustice (« faute que je n'ai pas commise »),
- tristesse, perte d'espoir,
- sentiment d'être pris au piège (pas d'issue, pas d'avenir).

Le monde ne se donne plus comme un espace ouvert à des possibles, mais comme un milieu fermé, lourd, où le sujet se sent coincé, exposé, vulnérable.

4.3. Hypothèse diagnostique

Même dans une perspective phénoménologique, il reste nécessaire de formuler une hypothèse diagnostique, mais celle-ci est envisagée comme une mise en forme de ce mode d'être-au-monde, non comme une simple étiquette.

Les éléments principaux sont :

1. *Évolution chronique* sur trois ans chez un sujet jeune, avec désinsertion progressive.
2. *Désorganisation du rapport au monde* : bizarreries comportementales, retrait, incohérence partielle du discours.
3. *Altération profonde du vécu du corps et de la pensée* : mutilation ressentie, transformation corporelle, pensées enregistrées.
4. *Expérience persécutive du monde et des autres* : surveillance, complot des femmes, hostilité des regards.
5. *Tonalité dépressive secondaire* : tristesse, apragmatisme, perte d'élan vital, mais apparaissant sur un fond de perturbation plus archaïque.

Tout cela oriente vers l'hypothèse d'une schizophrénie, comprise phénoménologiquement comme une modification radicale de la structure du monde vécu : rupture de l'évidence naturelle, altération des frontières entre soi et le monde, entre intérieur et extérieur, entre possible et réel.

Ainsi, au niveau I, on peut proposer : *Hypothèse de schizophrénie (avec manifestations thymiques secondaires)*.

4.4. Angoisse et tonalité de l'existence

Plutôt que de parler seulement de « types d'angoisse » au sens psychanalytique, on peut ici insister sur la forme globale de l'angoisse existentielle :

- *Angoisse de morcellement et d'atteinte de l'intégrité* : le corps n'est plus sûr ; il se transforme, est mutilé, exposé aux autres.
- *Angoisse d'intrusion* : invasion de la sphère intime (pensées enregistrées), difficulté à se sentir « chez soi » en soi-même.
- *Angoisse de persécution* : monde rempli de regards qui jugent, de femmes qui complotent, d'Autres qui surveillent.

Cette angoisse n'est pas seulement un « symptôme » de plus : elle colore l'ensemble de la réalité vécue. Elle modifie le sens des événements, des relations, du corps, du temps. Elle est la toile de fond à partir de laquelle Monsieur J. vit et interprète tout ce qui lui arrive.

4.5. Style de rapport au monde (point de vue phénoménologique)

On peut résumer le style d'existence de Monsieur J. par quelques traits :

- *Monde devenu opaque* : les évidences quotidiennes (aller en cours, faire des projets, sortir avec des amis) se défont. Ce qui était familier devient étranger, inquiétant.
- *Réduction du champ des possibles* : disparition ou appauvrissement des projets, repli dans la chambre, recherche de solutions centrées sur la mère ou sur des explications délirantes.
- *Surinvestissement du corps et du regard des autres* : le corps et l'image sont au centre, comme si l'identité ne pouvait plus se stabiliser autrement.
- *Expérience de désappropriation* : de la pensée, du corps, des relations (c'est l'Autre qui surveille, qui juge, qui enregistre).

Dans cette optique, le « délire » n'est pas pensé d'abord comme une construction arbitraire, mais comme une tentative de donner sens à un monde qui s'est défait dans son évidence.

4.6. Relations à autrui

Les relations d'objet peuvent être reformulées ici comme manières d'être-avec-les-autres :

- La relation à la mère est à la fois indispensable (il vit avec elle, c'est elle qui consulte) et profondément troublée (tentative de transgression incestueuse, confusion des places).
- La relation à l'amie n'a pas pu être intégrée comme une relation où l'autre existe avec ses propres choix ; la séparation déclenche une crise profonde, et le vécu se transforme en persécution généralisée par « toutes les femmes ».
- Les autres dans la rue sont perçus principalement à travers leurs regards, hostiles et méprisants.

Autrui n'apparaît plus comme un sujet à part entière avec qui une relation réciproque peut se construire, mais comme un foyer de menaces. On passe d'un monde partagé à un monde où le sujet est objectivé : regardé, jugé, surveillé.

4.7. Synthèse phénoménologique de la structure de personnalité

Au terme de cette analyse , on peut proposer la synthèse suivante :

- Monsieur J. est un sujet jeune chez qui se manifeste une structure psychotique de type schizophrénique, que l'on peut décrire phénoménologiquement comme une atteinte de base de la structure du monde vécu : rupture de l'évidence naturelle, fragilisation du sentiment d'identité, perturbation du rapport au corps et aux autres.
- Le délire (mutilation, micros, complot des femmes) apparaît comme une tentative de réorganiser un monde qui n'est plus fiable, de donner une cohérence à des expériences d'angoisse et de désorganisation très difficiles à supporter.
- La tonalité dépressive, la perte d'élan vital et le sentiment d'impasse s'inscrivent dans ce contexte de délitement du sens, plus que dans un trouble thymique isolé.
- La relation à la mère, l'échec de la relation amoureuse, l'abandon des études et l'isolement peuvent être compris comme des moments où se révèle la difficulté de Monsieur J. à habiter un monde partagé, structuré par des limites, des lois et des projets.

Cette perspective phénoménologique ne remplace pas l'approche diagnostique classique, mais elle permet de **mieux saisir ce que vit Monsieur J.**, au-delà des catégories, et de

réfléchir à un accompagnement qui tienne compte de son mode singulier d'être-au-monde.

Sommaire

LA COMPOSITION D'UNE ETUDE DE CAS

1. Schéma général (niveau I)
 - 1.1. *Présentation du patient*
 - 1.2. *Sémiologie*
 - 1.3. *Diagnostic psychiatrique*
 - 1.4. *Types d'angoisse*
 - 1.5. *Mécanismes de défense*
 - 1.6. *Relations d'objet*
 - Les relations à autrui
 - La culpabilité
 - Le narcissisme
 - Relation avec le psychologue
 - 1.7. *Organisation/structure de la personnalité*
 - Histoire
 - Construction œdipienne
 - Synthèse (évaluation psychopathologique)
2. Présentation détaillée (niveau II)
 - 2.1. *Analyse sémiologique*
 - 2.2. *Analyse diagnostique*
 - 2.3. *Analyse psychopathologique*
 - Étude du « mode de fonctionnement mental du sujet »
 - Analyse de l'histoire du sujet
 - Étude de la structure
 - Interprétation clinique

EXEMPLE (SEMILOGIE SIMPLE) :

MONSIEUR T., 48 ANS

EXEMPLE : MONSIEUR J. 21 ANS, SCHIZOPHRENIE

1. Observation
 - 1.1. *Présentation du cas*
 - 1.2. *Recueil sémiologique élémentaire*
2. Etude de cas (niveau I - licence)
 - 2.1. *Présentation du patient*
 - 2.2. *Sémiologie*
 - Chronologie et mode d'évolution
 - Signes cliniques principaux
 - Sphère thymique
 - Sphère de la pensée
 - Sphère comportementale et relationnelle
 - 2.3. *Diagnostic psychiatrique*
 - 2.4. *Types d'angoisse*

2.5. *Mécanismes de défense*

2.6. *Relations d'objet*

- Relations à autrui
- Culpabilité
- Narcissisme
- Relation avec le psychologue / thérapeute

2.7. *Organisation / structure de la personnalité*

- Histoire subjective et événements significatifs
- Construction œdipienne

2.8. *Synthèse psychopathologique*

3. Etude de cas (niveau II - master)

3.1. *Réorganisation de la sémiologie*

- Motif de la consultation
- Antécédents (personnels et familiaux)
- Histoire des troubles
- Épisode actuel
- Éléments médicaux
- Évolution
- Conclusion

3.2. *Discussion du diagnostic*

- Hypothèse
- Justification de l'hypothèse
- Définition de la forme clinique
- Exclusion des autres troubles

3.3. *Lecture psychopathologique - repérage d'éléments*

3.4. *Analyses psychopathologiques*

- Étude du "mode de fonctionnement mental du sujet"
 - Etude des mécanismes de défense
 - Etude du type de relation d'objet
 - Etude du type d'angoisse
 - Etude du symptôme et de la demande
 - Etude des modes d'investissements libidinaux
 - Analyse des relations avec l'interlocuteur
- Analyse de l'histoire du sujet
 - Liens temporels
 - Répétitions de l'histoire
 - Reconstruction de l'histoire par le sujet
- Étude de la structure
- Hypothèses cliniques

4. Etude de cas (perspective phénoménologique)

4.1. *Présentation du patient*

4.2. *Sémiologie dans une perspective phénoménologique*

- Temporalité et évolution
 - Depuis environ trois ans (vers 18 ans)
 - Épisode récent (après la rupture sentimentale)
- Expérience du corps et de soi

Expérience de la pensée

Expérience du monde et des autres

Tonalité affective globale

4.3. Hypothèse diagnostique

4.4. Angoisse et tonalité de l'existence

*4.5. Style de rapport au monde (point de vue
phénoménologique)*

4.6. Relations à autrui

*4.7. Synthèse phénoménologique de la structure
de personnalité*

SOMMAIRE